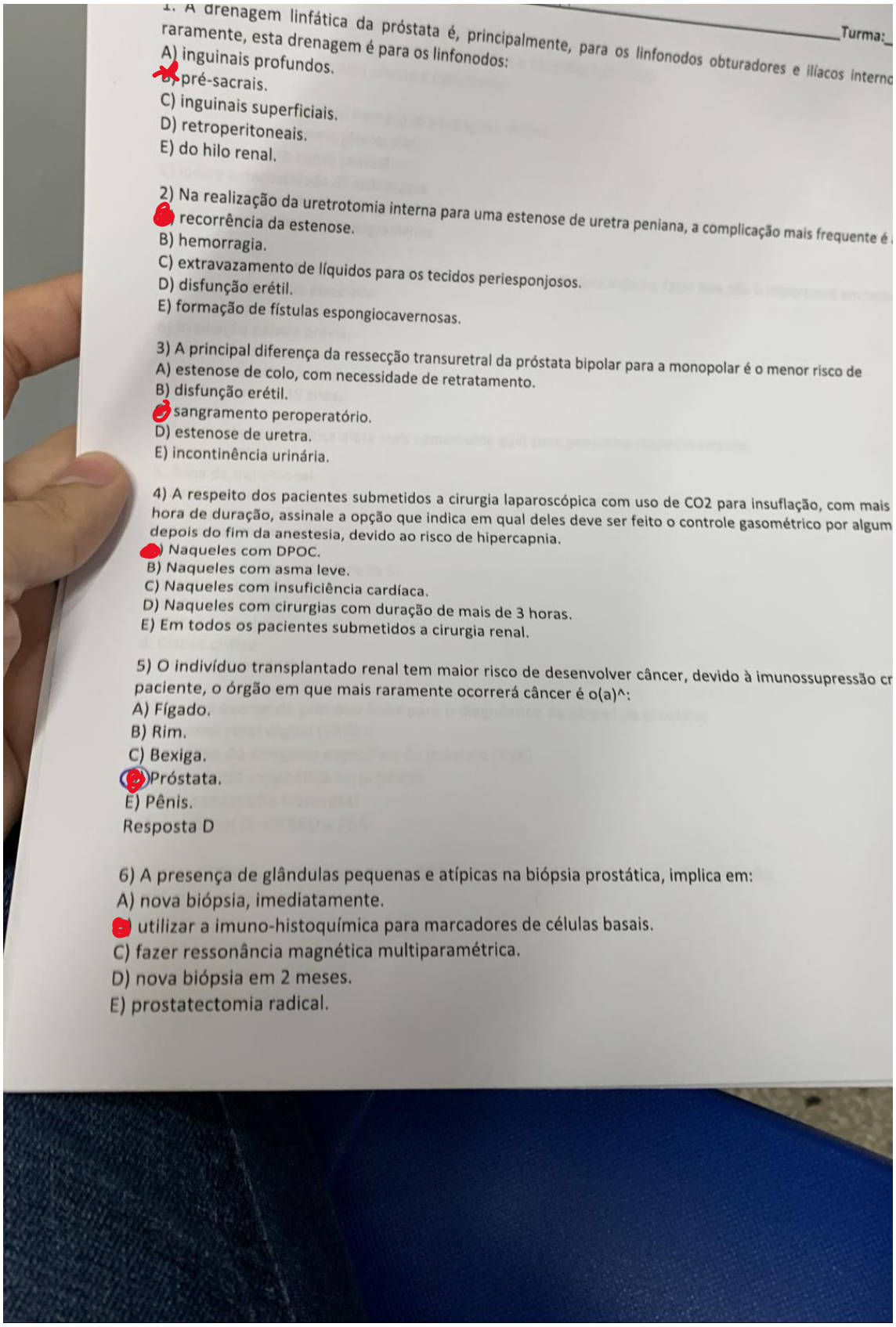
M2 - Uro/Nefro



Turma:

1. A drenagem linfática da próstata é, principalmente, para os linfonodos obturadores e ilíacos interno raramente, esta drenagem é para os linfonodos:
A) inguinais profundos.
B) pré-sacrais.
C) inguinais superficiais.
D) retroperitoneais.
E) do hilo renal.

2) Na realização da uretrotomia interna para uma estenose de uretra peniana, a complicação mais frequente é
A) recorrência da estenose.
B) hemorragia.
C) extravazamento de líquidos para os tecidos periesponjosos.
D) disfunção erétil.
E) formação de fístulas espongiocavernosas.

3) A principal diferença da ressecção transuretral da próstata bipolar para a monopolar é o menor risco de
A) estenose de colo, com necessidade de retratamento.
B) disfunção erétil.
C) sangramento peroperatório.
D) estenose de uretra.
E) incontinência urinária.

4) A respeito dos pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica com uso de CO_2 para insuflação, com mais hora de duração, assinale a opção que indica em qual deles deve ser feito o controle gasométrico por algum depois do fim da anestesia, devido ao risco de hipercapnia.
A) Naqueles com DPOC.
B) Naqueles com asma leve.
C) Naqueles com insuficiência cardíaca.
D) Naqueles com cirurgias com duração de mais de 3 horas.
E) Em todos os pacientes submetidos a cirurgia renal.

5) O indivíduo transplantado renal tem maior risco de desenvolver câncer, devido à imunossupressão cr paciente, o órgão em que mais raramente ocorrerá câncer é o(a)^:
A) Fígado.
B) Rim.
C) Bexiga.
D) Próstata.
E) Pênis.
Resposta D

6) A presença de glândulas pequenas e atípicas na biópsia prostática, implica em:
A) nova biópsia, imediatamente.
B) utilizar a imuno-histoquímica para marcadores de células basais.
C) fazer ressonância magnética multiparamétrica.
D) nova biópsia em 2 meses.
E) prostatectomia radical.

exceção de um. Assinale-o.
A) Boca seca.
B) Constipação intestinal.
C) Piora do glaucoma.
D) Hipertensão arterial.
E) Alterações cognitivas.

...nicos no tratamento da bexiga hiperativa pode provocar os sintomas listados a segu...

8) Durante uma prostatectomia radical de resgate, após radioterapia pélvica, é observada uma lesão retal de 2 cm. Assinale a opção que indica a conduta mais segura.
A) Reparo imediato em dois planos.
B) Colostomia apenas.
C) Reparo imediato em dois planos e sonda retal.
D) Interrupção da cirurgia, reparo em dois planos e bloqueio hormonal.
E) Reparo imediato em dois planos e colostomia.

9) No paciente idoso com hematúria e tabagista, define
A) o sangramento como glomerular.
B) o sangramento como caliceal.
C) indica a necessidade de cistoscopia.
D) indica a realização de citologia urinária.
E) não indica a origem do sangramento.

10) Sobre o paciente com micro hematúria, assinale a opção que indica o fator que não é importante em termos de risco de malignidade associada.
A) Tabagismo.
B) Irradiação pélvica prévia.
C) Exposição a corantes.
D) História familiar de hematúria.
E) Idade acima de 35 anos.

11) A neoplasia prostática afeta mais comumente qual zona prostática respectivamente:
a. Zona periférica
b. Zona de transicional
c. Zona central
d. Zona peri-uretral
e. Estroma fibromuscular

12) A úlcera de Hunner refere-se à:
a. Cistite eosinofílica
b. Cistite glandular
c. Cistite intersticial
d. Cistite cística
e. Cistite tuberculosa

13) Qual o exame de primeira linha para o diagnóstico de câncer de próstata:
a. O exame retal digital (ERD)
b. A análise do antígeno específico da próstata (PSA)
c. Ressonância magnética de próstata
d. Ultra-sonografia transretal
e. A combinação de ERD e PSA

14) Para o câncer de próstata de muito baixo risco qual tratamento é recomendado:
A) Prostatectomia radical
B) Radioterapia
C) Vigilância ativa
D) Quimioterapia
E) Hormonioterapia

Qual a mais frequente complicação de cirurgia de próstata:
a- Disfunção erétil
b- Incontinência urinária
c- Incontinência fecal
d- Fistula urinária
e- Hematúria

16) Paciente de sexo masculino, 26 anos, com vida sexual ativa (várias parceiras nos último meses), apresentando adenomegalia inguino/femoral direta, progressiva, com aparecimento de sinais flogísticos, drenando secreção purulenta, espontaneamente através de vários pontos e com sinal do sulco (separação dos nódulos linfáticos inflamados da região inguinal dos da femoral, permanecendo-os acima e abaixo do ligamento de Poupart), já apresentando dor e dificuldade para defecar, com fistulização retal. Nega ter tido lesões ulceradas no pênis (sic). Para confirmar a hipótese clínica mais correta para esta situação, dentre os exames abaixo, qual seria o mais indicado e confirmaria o diagnóstico?
A) Bacterioscopia pelo Gram da secreção do bulbão, com ênfase a pesquisa de diplococos Gram negativos, intra e extracelulares.
B) Pesquisa de Clamidia na secreção do bulbão, através, por exemplo, de Imunofluorescência direta da secreção ou pesquisa por reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para Clamidia.
C) Pesquisa de corpúsculo de Donovan (em secreção corada pelo Leishman ou biópsia corada pelo Giemsa).
D) Pesquisa de bacilos Gram negativos através de Bacterioscopia pelo Gram da secreção drenada do bulbão ou Cultura para Haemophilus ducreyi

17) Paciente de 36 anos de idade, feminina, apresentando queda de cabelo, dores articulares e dor no corpo e nas últimas semanas vem apresentando "inchaço" e edema de membros inferiores. O exame Fator Anti Nuclear (FAN) apresentou-se positivo, com título de 1280 e padrão nuclear pontilhado fino. O seu EAS apresentou o seguinte resultado

Exame Físico/Químico
COR- Amarelo escuro (V.R:Am.citrino) CHEIRO-"Sui Generis"(V.R:"Sui Gen")
ASPECTO- Lig. Turvo(V.R:Límpido) DEPÓSITO-moderado (V.R:Ausente)
DENSIDADE- 1025 (V.R:1015 a 1025), pH- 6.0 (V.R:áçido)
NITRITO- Negativo (V.R:Negativo) PROTEÍNAS- 2800mg/dL(V.R:30 mg/dL)
GLICOSE- 0 mg/dL (V.R: 0 mg/dl) CORPOS CETÔNICOS-Ausente (V.R-Aus.) UROBILINOGÊNIO-1mg/dL(V.R:1)
BILIRRUBINA-Ausente (V.R:Ausente).HEMÁCIA-Presente(+/4+) (V.R:Aus.)
HEMOGLOBINAS-Presente(V.R:Ausente)
Exame Microscópico
LEUCÓCITOS-15.000/mL (V.R:até 10.000/mL) MUCO-Presente(++/4+)
HEMÁCIAS TOTAL- 20.000/mL(V.R:até 10.000/ml) Hm.ISOMÓRFICAS-15.000/mL
Hm.DISMÓRFICAS- 5.000/mL (V.R:5% das Hm.Total)
Cel.UROTELIAIS-15.000/mL (V.R:até 10.000/mL) Cel.TUBULARES- 8.000 /mL (V.R: até 1.500/mL)
CRISTAIS-de oxalato de cálcio(+/4+)
CILINDROS HIALINOS- 4000/mL (até 1750/mL)
OUTROS CILINDROS - Gordurosos: 2000/mL (V.R: 0)
NO SORO: COLESTEROL:340 mg/dL (V.R:<200 mg/dL) ALBUMINA:2.9mg/dL(V.R:4.5-5.5mg/dL)

Considerando a exposição acima, com estes dados, responda que enfermidade melhor explicaria estes achados clínicos/ laboratoriais?
A) Síndrome nefrítica-Glomerulonefrite Aguda (GNDA)
B) Síndrome nefrótica-Nefropatia lúpica
C) Síndrome nefrítica-Nefropatia lúpica
D) Síndrome nefrótica-Glomerulonefrite Aguda (GNDA)

18) EM UM PACIENTE INTERNADO COM SUSPEITA DE SEPSIS, QUAL EXAME DEVE SER SOLICITADO PARA AVALI
UMA POSSÍVEL INJÚRIA RENAL AGUDA (IRA) (Escolha a melhor alternativa dentre as abaixo)?
A) Ácido úrico sérico
B) Uréia sérica
C) NGAL
D) Nitrogênio Ureico Sérico (BUN)

19) Qual paciente com doença renal crônica na classificação KDIGO tem maior chance de morrer?
a) G2A1
b) G5A3
c) G4A2
d) G3A3

20) Qual dessas fórmulas é a mais recomendada atualmente para cálculo da taxa de filtração glomerular em adultos?
a) Cockcroft-Gault
b) CKD-EPI
c) MDRD
d) CKD-EPI 2021
e) Schwartz

21) Qual dessas fórmulas é a mais recomendada atualmente para cálculo da taxa de filtração glomerular em crianças?
a) Cockcroft-Gault
b) CKD-EPI
c) MDRD
d) CKD-EPI 2021
e) Schwartz

22) Na nefropatia por lesões mínimas (nefrose lipoídica) as células mais afetadas são:
a) Endoteliócitos
b) Mesangiócitos
c) Podócitos
e) Histiócitos

23) De acordo com a fisiopatologia que acomete as doenças glomerulares, escolha o diagnóstico que melhor relacione fisiopatologia e doença, respectivamente:

a. Depósito de imunocomplexo na luz do capilar glomerular - Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa.
b. Lesão da membrana basal glomerular associada a anticorpo anti-membrana basal - Doença por Lesão Mínima.
c. Lesão da membrana basal glomerular associada a anticorpo anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA) – Glomerulopatia membranosa.
d. Deposito de imunocomplexo na membrana basal glomerular com apagamento difuso dos podócitos – Glomerulonefrite pós estreptocócica (GNPE).

24) Paciente do sexo feminino, 25 anos, procura atendimento com queixa de edema peri-orbital, diminuição da diurese, urina escura, cefaleia, escotomas visuais, embaçamento visual, dispneia progressiva. Ao exame físico encontra-se hipertensa (PA 220/140 mmHg), edema periorbital importante e estertores pulmonares bilaterais. Traz exames de outro serviço que mostram FAN + 1:320, padrão pontilhado fino, complemento C3 e C4 consumidos, anti-DNA reagente, creatinina 1,8 mg/dL, EAS com hematúria, proteinúria, leucocitúria e cilindros hemáticos. Suas principais hipóteses diagnósticas sindrômica e etiológica são respectivamente:
a. Síndrome Nefrótica – Glomerulonefrite membranosa idiopática
b. Sindrome Nefrótica- Glomeruloesclerose segmentar e focal
c. Sindrome Nefritica – Nefrite lúpica (glomerulonefrite proliferativa)
d. Glomerulonefrite rapidamente progressiva – Síndrome do Bom Pastor.

25) Paciente do sexo masculino, 52 anos inicia quadro compatível com síndrome nefrótica, e encaminhado a biópsia renal e realização de exames. O resultado da biópsia renal mostra membrana basal glomerular espessada na coloração por hematoxilina-eosina (HE) e presença de espículas (spikes) na coloração pela prata. Realiza também pesquisa de anti-PLA2R sérico que veio positiva, com títulos elevados. De acordo com estes dados, sua princip hipótese diagnóstica é:
a. Doença por lesão mínima
b. Nefropatia membranosa primária
c. Glomeruloesclerose segmentar e focal
d. Glomerulonefrite membranosa secundária

6) Paciente com diagnóstico recente de HIV, com carga viral elevada e CD4 baixo, procura serviços médicos devid quadro compatível com síndrome nefrótica onde foi submetido a biópsia renal. Das formas de doença glomerula associada ao HIV, destaca-se a:

a. Doença por lesão mínima
b. Glomerulonefrite membranoproliferativa
c. Doença de Berger (nefropatia por IgA)
d. Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF colapsante)

27) Homem de 56 anos com creatinina alta há 4 meses (para determinar Doença Renal Crônica as alterações devem ser >= 3 meses), creatinina = 4,0mg/dL (valor relativo normal = 0.4 a 1.2 mg/dL). Qual o diagnóstico provável?

a) Injúria Renal Aguda.
b) Doença Renal Crônica.
c) Rins normais.
d) Doença Renal Aguda.

28) Marque a alternativa certa quanto ao diabetes e o rim:

a) Na nefropatia diabética a microalbuminúria está acima de 300mcg/mg de creatinina.
b) Na doença renal do diabetes se a taxa de filtração glomerular estiver acima de 100ml/min/1,73m2SC, esse diagnóstico não é confirmado.
c) Na glomerulopatia diabética ocorre a hialinose de arteríolas aferentes, poupando as arteríolas eferentes.
d) O último estágio da doença renal do diabetes é atingido pela minoria dos diabéticos.

29) Em um paciente adulto com múltiplos cistos renais, a maior chance de diagnóstico é:

a) Esclerose tuberosa.
b) Doença renal policística autossômica dominante.
c) Rim em esponja medular.
d) Doença renal policística autossômica recessiva.

30) No paciente grande queimado, qual destes distúrbios eletrolíticos que você espera encontrar?

a) Hiponatremia HIPOVOLÊMICA
b) Hipernatremia HIPERVOLÊMICA
c) Hiponatremia HIPERVOLÊMICA
d) Hipernatremia HIPOVOLÊMICA

31) Na necrose tubular aguda, a sobrevida do paciente é

a) Maior na medida em que avança na classificação do KDIGO
b) Maior na medida em que ocorre comprometimento de outros órgãos
c) Menor na pré-renal que na renal
d) Menor na anúria que na não oligúrica.

32) Paciente de 22 anos de idade, com síndrome urêmica, hipertenso, oligúrico. Fez exames que mostram ureia plasmática = 320mg/dl e creatinina 22 mg/dl. Outros exames deverão com maior probabilidade mostrar:

a) Hipernatremia
b) Hipercalemia
c) Alcalose metabólica
d) Hipomagnesemia.

33) Paciente hipertenso, com TFG = 22ml/min/1,73m2SC,, a qual é reduzida há anos, apresenta anemia, hemoglobina = 8 g/dl . O que pode contribuir para essa anemia?

a) Aumento da ligação do ferro às metahemoglobinas
b) Diminuição pelo fígado da liberação de hepcidina.
c) Uso de anti-inflamatórios não hormonais.
d) Intoxicação por vitamina B12.

34) Na síndrome cardiorrenal tipo 1 encontramos:

a) Alteração aguda da função renal levando a insuficiência cardíaca
b) Alteração sistêmica afetando ao mesmo tempo rim e coração
c) Alteração cardíaca aguda levando a disfunção renal
d) Alteração renal crônica levando a comprometimento cardíaco

a) Quanto à sobrevivência na doença renal crônica terminal
a) A diálise peritoneal oferece maior sobrevida que a hemodiálise
b) O paciente diabético apresenta sobrevida semelhante ao de glomerulonefrite crônica.
c) O transplante renal oferece maior quantidade de vida que a diálise.
d) No transplante renal intervivos a sobrevida é menor que no cadavérico.

36) Na doença mineral óssea que acomete o portador de doença renal crônica terminal, a osteomalácia é devido a:
a) Intoxicação pelo alumínio
b) Hiperparatiroidismo terciário
c) Iatrogenia por excesso de vitamina D e análogos
d) Deficiência de cálcio

37) A furosemida:
a) Inibe a bomba Na-K-ATPase basolateral
b) Bloqueia o canal de K luminal
c) Bloqueia o cotransportador Na-K-2Cl luminal
d) Diminui a permeabilidade a íons dos espaços intercelulares

38) Os estudos laboratoriais de uma mulher hipertensa (160/110 mmHg) mostram níveis séricos de potássio muito baixo (2,7 mEq/L) e alto nível de sódio e H2CO3. A associação de ..... será a mais adequada nessa paciente.
A. Espironolactona + Hidroclorotiazida
B. Furosemida + clorotiazida
C. Hidroclorotiazida + Glicerina
D. Manitol + Acetazolamida

39) A nefropatia medicamentosa ocasionada pelo uso constante de analgésicos e anti-inflamatórios é um dos principais problemas enfrentados por pacientes portadores de doenças crônicas de origem inflamatória, os quais fazem tratamento à base destes medicamentos. Em relação à nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios, assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) não seletivos para COX-2 são capazes de desencadear a nefropatia induzida por anti-inflamatórios.
B) A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por uma redução da produção dos eicosanóides prostaglandina E2 e prostaciclina no rim, os quais estão envolvidos na manutenção da homeostase do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular.
C) A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por um excesso deposição de metabólitos inativos destes medicamentos na membrana de filtração do glomérulo.
D) Todas as alternativas estão corretas.

40) Em relação ao tratamento da Hiperplasia Prostática Benígna (HPB), assinale a alternativa CORRETA.
A) Para a redução do volume prostático é indicado o uso de fármacos inibidores da enzima 5α redutase que é responsável pela hidrólise do hormônio di-hidrotestosterona. Desta forma ocorrerá uma redução na liberação de fatores de crescimento e aumento (consequentemente) da proliferação celular no tecido prostático.
B) O tratamento dos sintomas do trato urinário inferior na HPB é feito a partir da utilização dos antagonistas dos receptores α1-adrenérgicos, tendo como efeito principal o relaxamento do colo da bexiga e uretra prostática.
C) Os antagonistas dos receptores α1-adrenérgicos que possuem maior seletividade para os subtipos de receptores α1A e α1C, não apresentam os efeitos adversos de hipotensão ou ejaculação retrógrada.
D) Todas as alternativas estão corretas.

M1 – Megazord

1. Sobre a reabilitação nas patologias ortopédicas:
A. Atua no diagnóstico e tratamento das patologias ortopédicas, não sendo escopo de sua atuação a prevenção.
B. O objetivo final da reabilitação é devolver ao indivíduo o máximo de funcionalidade dentro do seu contexto.
C. No tratamento da Dor Crônica, o médico fisiatra utiliza apenas a prescrição de fisioterapia para melhora do paciente.
D. A reabilitação pós fratura só deve iniciar após cerca de 8-12 semanas, independente do local da fratura, gravidade, ou técnica utilizada na estabilização,tendo pouco benefício o início precoce.

2. Você é chamado para avaliar um paciente adulto no pronto socorro. No exame, o paciente apresenta uma grande queimadura no braço esquerdo e no tóráx, envolvendo quase todo o membro superior esquerdo e metade do tronco anterior. Qual a sua estimativa para a extensão da queimadura?
A. 12%
B. 18%
C. 24%
D. 28%

3. Na displasia de desenvolvimento do quadril:
A. O teste de Barlow é uma manobra que detecta a luxação do quadril com a sua flexão e adução.
B. O teste de Galleazzi é sempre anormal, mesmo na presença dessa patologia nos quadris bilateralmente.
C. O Suspensório de Pavlik deve ser usado mesmo em luxações teratológicas do quadril.
D. A redução cruenta associada à osteotomia de fêmur derrotativa e com encurtamento além de osteotomia de Salter, combinadas são indicadas em crianças de 12 meses de idade.

4. Um paciente com 6m de Trauma raquimedular apresenta-se com Babinsky, clônus de membros inferiores e reflexo de Hoffmann positivo. Qual a altura provável da lesão do paciente?
A. C4C5
B. T8T9
C. T12L1
D. L4L5

5. Paciente 18 anos, sexo feminino, foi vítima de acidente motociclístico, queixando-se de dor intensa em membro superior D, na região antebraço. No momento do exame físico pela equipe pré-hospitalar foi visto deformidade em antebraço. Paciente foi encaminhada ao Pronto Socorro de Ortopedia, realizado radiografia do antebraço e visualizado fratura de rádio e ulna na região diáfisária com desvio. Foi indicado cirurgia, porém paciente terá que aguardar a vaga ser liberada, e por isso foi imobilizada. Qual o tipo de imobilização que deve ser usada:
A. Inguino-podálica
B. Antebraquio-palmar
C. Axilo-palmar
D. Tóraco-braquial

6. No exame físico de paralisia obstétrica alta encontramos:
A. Reflexo de Moro assimétrico
B. Reflexo de preensão ausente
C. Mão em garra
D. Membro em rotação externa e supinação do antebraço

7. Os seguintes sintomas estão presentes ao suspeitar de uma fratura:
I- dor local

...dema ou deformidade
... hematoma
...V- crepitação ao movimentar ou incapacidade funcional do membro
V- muita sede
VI- temperatura alta

Dos itens acima mencionados, os que são realmente identificados como presença de possível fratura:
A. I, IV
B. I, IV, V, VI
C. II, III, V, VI
D. I, II, III, IV

8. Em relação às fraturas expostas, marque a alternativa correta:
A. A classificação de Gustillo leva em consideração, principalmente, o tamanho do ferimento (até 1, de 1 a 10 e maior de 10 cm).
B. Paciente trabalhador rural, apresentou queda do cavalo no curral com fratura da perna com ferimento de aproximadamente 4 cm ao nível da fratura. O seu diagnóstico é: fratura exposta da perna grau II de Gustillo.
C. A complicação mais temida na fratura exposta é a infecção e por isso é muito importante a limpeza e desbridamento desses ferimentos.
D. O tratamento da fratura exposta pode ser conservador, principalmente nos casos com mais de 6 horas de exposição.

9. Com relação a hora de ouro do ATLS, é correto afirmar que:
A. A melhora do tempo de resposta do resgate não influência na sobrevida;
B. As mortes que ocorrem após a primeira semana do trauma decorrem principalmente do estado de choque;
C. A mortalidade aumenta em pacientes graves e internados por longos períodos devido a infecções;
D. Nenhuma das anteriores;

10.Você está descrevendo os riscos e benefícios da expansão tecidual para os pais de uma criança que apresenta uma área de alopecia no couro cabeludo. Qual das seguintes alternativas constitui a principal vantagem da expansão tecidual para esta criança?
A. O menor número de procedimentos com anestesia geral
B. O menor número de consultas clínicas hospitalares
C. O defeito pode fechar diretamente utilizando um retalho de pele com cabelo
D. A reconstrução pode ser terminada rapidamente

11. Dentro dos critérios de diagnóstico de **Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)**, em relação ao Exame denominado FAN, nas reuniões de Consenso Nacional de Laudos de FAN em Células HEP2 , foram criados estes algoritmos: (Dellavance e cols, mod. Rev Bras Reumatol, v. 47, n.4, p. 265-275, jul/ago, 2007):

CORRELACIONES AS COLUNAS (A e B) E ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA:

A) PADRÕES NUCLEARES EM CÉLULAS HEP2
I- Nuclear Homogêneo periférico, Placa metafásica cromossômica negativa, tipo membrana nuclear contínua
II- Nuclear Homogêneo, Placa metafásica cromossômica positiva
III- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica positiva, Centromérico
IV- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica positiva, Pontilhado Fino Denso
V- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica negativa, Grosso
VI- Nuclear Pontilhado, Placa metafásica cromossômica negativa, Fino

B) RELEVÂNCIAS CLÍNICAS POR AUTOANTICORPOS MAIS IMPORTANTES:
1- Anticorpo anti-proteína p 75 kDa, Ag LEDGF/p75 (lens epithelium-derived growth factor). Não est... associado a doença autoimune. Pode ser encontrado na Cistite Intersticial, Tumor de Mama, Processo... inflamatórios inespecíficos: pode ser encontrado em indivíduos saudáveis, Dermatite Atópica, Psoríase, Asma
2- Anticorpo anti-DNA nativo: Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). **Anticorpo anti-Histona**: L... induzido por drogas (hidralazina, procainamida, isoniazida e clorpromazina); LES idiopático. **Anticor... anti-cromatina (DNA/Histona, nucleossomo)**: Artrite Reumatóide (AR); Artrite Idiopática Juve... mportante associação com uveíte na forma oligoarticular; Síndrome de Felty; Cirrose Biliar Primária

Anticorpo anti-SSA/Ro: Ag - 4 pequenos RNAs associados a 2 proteínas de 60 e 52Kd.A de 60 Kd - ...pus, LNN, SS. A de 52 Kd SS, ES, Miosite, LES,DMTC, AR, CBP, HAI, HVB, HVC. Ocorre na maioria dos pacientes com Síndrome de Sjögren (88 a 96%), Artrite reumatóide (24 a 60%), Lupus associado a fotossensibilidade em paciente jovem, Lupus neonatal (90%), bloqueio cardíaco congênito
Anticorpo anti-SSB/La: Lúpus neonatal; LES; SS. Ag - proteína 48KD, parece ter função com fator terminal na transcrição da RNA polimerase III. Frequentemente associado a SSA/Ro, SS primária (71 a 87%), Lupus neonatal (75%), incluíndo BCC (30 a 40%), Lupus (9 a 35%). SS está associado a púrpura, hipergamaglobulinemia, disfunção severa da glândula salivar, edema de parótida, altos níveis de fator reumatóide, linfopenia e leucopenia.
Anticorpo anti-Mi-2: Dermatomiosite, embora raramente ocorra na polimiosite do adulto.
4- Anticorpo anti-Lamina, Componente da membrana interna, pontos de ancoragem de cromossomos de células em interfase, pode ser encontrado nas Hepatites auto-imunes, raramente associado a doenças reumáticas (algumas formas de LES e esclerodermia linear, vasculite cerebral ou cutânea)
5- Anticorpo anti-centrômero: Esclerose Sistêmica forma CREST(curso benigno e prolongado), Esclerodermia (50 a 82%), Cirrose Biliar Primária(8%)
6- Anticorpo anti-Sm: 99% de especificidade para Lupus. Relação com doença ativa independente do título, relação mais frequente com acometimento do SNC, doença renal, fibrose pulmonar e pericardite.
Anticorpo anti-RNP: Muitos casos associados a Sm. Critério obrigatório no diagnóstico da Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC- relaciona com altos títulos); também ocorre no LES (30 a 40%,doença menos severa), Esclerose Sistêmica (ES) e AR.

A SEQUÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CORRETA É:
A. I- 4; II- 2; III-1; IV- 6; V-5 ; VI- 3
B. I- 1; II- 5; III- 6; IV- 4; V- 3; VI- 2.
C. I- 4; II-1; III-5 ; IV-2 ; V-3; VI- 6.
D. I- 4 ; II- 2 ; III- 5 ; IV- 1 ; V- 6 ; VI- 3

12.Correlacione adequadamente as colunas, cada anticorpo com a doença em que ele mais frequentemente está positivo:
1.Anti-histonas 2.c-ANCA 3. Anti-RNP 4. Anti-DNA nativo 5.Anti-SSA/RO
( ) Doença Mista do Tecido Conjuntivo
( ) Nefrite Lúpica
( ) LES induzido por drogas
( ) Granulomatose com Poliangeíte - ex Granulomatose de Wegener
( ) Síndrome de Sjögren

A sequência correta está em:
A. 3,4,1,2,5
B. 1,2,3,4,5
C. 1,5,4,2,3
D. 5,1,2,4,3

13.Considerando o laboratório na análise das causas mais frequentes de anemias no idoso, analise as afirmações abaixo e depois escolha a sequência de afirmações corretas (verdadeiras).
I- O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de descriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferro.
II- O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de descriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferritina.
III- A Contagem de Reticulócitos é muito útil na diferenciação da Anemia Ferropriva da Anemia Megaloblástica, também importante causa de anemia no idoso.
IV- A pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser solicitada quando estivermos diante de uma anemia microcitica e hipcrômica, com anisocitose.
A alternativa com as afirmações corretas (verdadeiras) é:
A. II e IV
B. I, III e IV
C. II, III e IV
D. I e IV

14. Uma paciente de 88 anos foi admitida no serviço de urgência com fraqueza como queixa principal. Apresentava dispneia, sintomas gastrointestinais como náuseas e vômitos, dor abdominal, dispepsia, prurido e feridas na boca há 3 dias. Os sintomas foram progressivos. Na avaliação dos medicamentos consumidos foi determinado que ela está em uso contínuo de metotrexato (MTX) há cerca de 5 meses. Na busca da causa do uso de MTX e checagem das prescrições, foi revelado que a paciente recebeu por

...ano MTX ao invés de digoxina. Ela havia usado MTX 1,25 mg por 5 meses consecutivos, e 2,5 mg ...nco dias por semana no último mês. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que ...indica a melhor opção terapêutica a ser instituída:

A. A retirada do MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)
B. A retirada do MTX e a administração de ácido fólico
C. A retirada do MTX e a administração de vitamina E
D. Continuação com MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)

15.Um paciente com insuficiência renal crônica em tratamento conservador, foi internado na Unidade Coronariana com angina instável. Apresentou, durante sua internação, quadro agudo de artrite na articulação metatarsofalangeana e tornozelo. Relatou que já havia sofrido quadro semelhante previamente. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que melhor indica o diagnóstico de artrite e opção terapêutica a ser instituída.

A. Artrite reumatóide e Colchicina.
B. Gota e Alopurinol.
C. Gota e Anti-inflamatório não hormonal.
D. Gota e Corticosteroides.

16.Sobre a artrite reumatoide, julgue as alternativas e responda:

I.	A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico a sinóvia e causa o acúmulo de líquido nas articulações, perda debilitante de cartilagem, fraqueza óssea e deformidade articular. É uma condição crônica e progressiva, podendo haver longos períodos de remissão (sem sintomas).
II.	Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com metotrexato.
III.	Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com um inibidor do fator de necrose tumoral (TNF) como monoterapia.
IV.	Paciente com artrite reumatoide estabelecida em caso de falha da monoterapia inicial com um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), por exemplo metotrexato, é indicada uma terapia com a combinação dupla ou tripla de DMARD convencional (Metotrexato, leflunomida, sulfassalazina, cloroquina e hidroxicloroquina).

A. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D. Todas as alternativas estão corretas.

17. A respeito dos fármacos antirreumáticos modificadores da doença, julgue as alternativas e responda:

I.	O metotrexato é um fármaco de primeira escolha, que tem atividade citotóxica e imunossupressora.
II.	A tempo de ½ vida da leflunomida é reduzida pela interação medicamentosa com colestiramina A.
III	A ciclosporina inibe a atividade dos linfócitos T efetores CD8+.
IV.	O tofacitinibe e o baricitibe são anticorpos monoclonais que inibem a via de sinalização JAK-STAT.

A. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D. Todas as alternativas estão corretas.

18.As bengalas são dispositivos auxiliares da marcha, (DAM) e, também, consideradas como órteses de membros inferiores, utilizadas com várias finalidades, como para aumentar o equilíbrio durante a deambulação e reduzir a descarga de peso de um dos membros inferiores durante a fase de apoio da marcha. Assinale a alternativa que descreve forma correta de utilização de uma bengala para uma paciente com osteoartrite de joelho direito.

A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior contralateral.

B. A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro inferior homolateral.

C. A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior homolateral.

D. A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro inferior contralateral.

19. Sobre o Delirium ou estado confusional agudo em pacientes idosos, marque a alternativa correta:

A. Um dos instrumentos utilizados para o seu diagnostico é o questionário CAM (Confusion Assesment Method).

B. É uma situação cada dia mais rara em idosos tendo em vista a elevada prevalência de doenças crônicas nesta população.

C. Caracteriza-se pela apresentação insidiosa e progressiva de déficits de memória, cálculo e linguagem.

D. A droga de escolha para o seu tratamento, independente se hiper ou hipoativo, é a administraçãode haloperidol por via endovenosa.

20. Uma senhora de 88 anos residente em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) e portadora de doença de Alzheimer em fase grave foi transferida para o hospital às 14 horas para tratamento de pneumonia aspirativa. No hospital, foi necessária sedação com haloperidol para início da antibioticoterapia venosa com cefatriaxona e clindamicina. No dia seguinte, por volta das 21 horas, a enfermeira do plantão, ao trocar a fralda da paciente, observou eritema persistente na região sacral sem perda de continuidade da pele. Que tipo lesão de pele essa paciente apresenta?

A. Dermatite de contato pelo uso de fralda.

B. Lesão por pressão estágio I

C. Candidíase moderada pelo uso de antibióticos.

D. Alergia aos antibióticos

21. Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (GDS) é um bom instrumento para o rastreamento de sintomas depressivos em idosos porque:

A. permite a detecção da sintomas depressivos associados às demências.

B. permite a diferenciação entre sintomas depressivos e a reação ao luto.

C. não inclui perguntas sobre os sintomas somáticos da depressão.

D. permite detectar aqueles que apresentam maior risco de suicídio.

ATENÇÃO: As questões 22 e 23 referem-se ao caso clínico:

A Senhora MASV, de 78 anos, é portadora de depressão, hipertensão arterial, osteoartrite de joelhos e diabetes com polineuropatia. Ela faz uso de três comprimidos ao dia de acordo com seguinte esquema terapêutico:

- 1 (um) comprimido pela manhã de formulação comercial que contém Olmesartana (bloqueador de receptor de angiotensina) 20mg + Hidroclorotiazida (diurético tiazídico) 12,5 mg + Anlodipino (bloqueador dos canais de cálcio) 5 mg para tratamento da hipertensão arterial.

TGUG Teste	25 segundos
Barthel	80 pontos (dificuldades para se vestir, incontinência ocasional e necessidade de supervisão para subir escadas)
Pfeffer	13 pontos (dificuldades com manuseio do dinheiro, com os medicamentos, fazer compras, preparar comida, encontrar o caminho de volta para a casa e ficar só em casa por muito tempo)
MEEM	23 pontos
Fluência verbal semântica:	9 nomes de animais
Teste do desenho do relógio	1 ponto (escore de Shulman)
Escala de Depressão Geriátrica	3 pontos

APGAR da família	10 pontos
Mini Avaliação Nutricional	11 pontos (risco de desnutrição)
Força de preensão manual	21 Kg
DXA	Massa muscular esquelética apendicular dividida pela altura ao quadrado: 6,3 Kg/m²
Hemograma, função renal, hepática e tiroidiana, vitamina B12, glicemia, lipidograma e eletrólitos	Normais
VDRL e anti-HIV	Negativos
Ressonância magnética do crânio	Atrofia cerebral difusa compatível com a idade. Lobos temporais mediais e hipocampos preservados. Discreta microangiopatia

- 1 (um) comprimido à noite de formulação comercial que contém Metformina (biguanida) 1000 mg + Sitagliptina (Inibidor de DPP-4) 100mg para tratamento da diabetes.
- 1 (um) comprimido à noite de Amitriptilina (antidepressivo tricíclico) 75 mg para a depressão e para dor.

22.Sobre o esquema terapêutico, pode-se afirmar que a Sra. MASV
A. tem polifarmácia e faz uso de uma medicação considerada inapropriada para idosos.
B. não tem polifarmácia e nem faz uso de medicação considerada inapropriada para idosos.
C. não tem polifarmácia, pois usa 3 comprimidos ao dia, mas faz uso de medicação inapropriada para idosos.
D. tem polifarmácia, mas não faz uso de medicação considerada inapropriada para idosos.

23.Ainda sobre o caso clínico da Sra. MSAV, com relação às suas doenças, pode-se afirmar que:
A. ela não tem multimorbidade, mas têm uma complicação de doença crônica.
B. ela tem multimorbidade complexa e apresenta uma complicação de doença crônica.
C. ela tem apenas multimorbidade, sem nenhuma complicação de doença crônica.
D. ela tem uma doença índice, várias comorbidades e uma complicação de doença crônica.

ATENÇÃO: as questões 24, 25, 26 e 27 referem-se ao caso clínico:

O senhor JPC, de 77 anos, engenheiro aposentado, é portador de hipertensão arterial e diabetes. Faz uso de Losartana, Glicazida e Metformina. Familiares relatam que há 6 meses vem apresentando quedas frequentes, lentidão para deambular, postura encurvada e rígida, tremores nas mãos, recusa alimentar, tosse ao ingerir líquidos e perda de peso. Além disso, sua memória está ruim, alterando períodos de muita lucidez e períodos de confusão nos quais relata que tem uma família com três crianças vivendo na área de serviço do apartamento. Nada o demove disso, descreve a aparência das crianças e chega a levar suco e doces para elas. Ele apresenta os seguintes resultados na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) e de exames:

24.De acordo com a história clínica, a avaliação cognitiva e funcional da AGA e exames pode-se afirmar que o Sr. JPC tem
A. provável demência vascular.
B. possível demência da doença de Parkinson.
C. provável demência com corpos de Lewy.
D. possível demência frontotemporal variante comportamental.

25.Sobre a função muscular do Sr. JPC é correto afirmar que ele:
A. não tem sarcopenia, pois as quedas, a lentidão e as dificuldades de mobilidade são explicadas pelo quadro neurocognitivo.
B. tem provável sarcopenia, mas isso já indica o início de medidas terapêuticas e de reabilitação.
C. tem sarcopenia, pois a força muscular está diminuída e o paciente apresentou quedas repetidas.
D. tem sarcopenia grave confirmada pelas alterações da força, massa e desempenho musculares.

26.Com os dados da história e da AGA, aplique a escala clínica de fragilidade para o Sr. JPC.
A. Em terminalidade – 9

Moderadamente frágil – 6
Levemente frágil – 5
D. Não frágil, mas regular – 3

27.A AGA é útil não só para o diagnóstico de deficiências e incapacidades, mas pode contribuir para o diagnóstico etiológico, ou seja, das doenças, como também é importante para definição do plano terapêutico e dos profissionais da equipe multidisciplinar necessários. Em um cenário do SUS, com dificuldades de acesso a equipes multidisciplinares, e baseando-se nos dados da AGA, para quais profissionais você encaminharia, inicialmente, o senhor JPC visando a manutenção por mais tempo de sua capacidade funcional.
A. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista.
B. Neuropsicólogo, fisioterapeuta e massagista.
C. Nutricionista, enfermeiro e educador físico.
D. Fisioterapeuta, educador físico e reeducador postural.

28.Assinale a sequência correta:
Escolha V para as afirmativa verdadeira e F para as alternativas falsas em relação a artrite reumatoide.
( ) A rigidez matinal e os nódulos de Heberden são critérios de diagnóstico
( ) O padrão de envolvimento articular mais frequente é a poliartrite de pequenas articulações
( ) A glicosamina e a condroitina são as drogas de escolha para previnir as erosões
( ) O fator reumatoide contribui para o diagnóstico e em altos títulos indica pior prognóstico.
A. V, V, F,F
B. F, V, F, V
C. F, V, F, F
D. V, F, V, F

29.Em relação a espondilite anquilosaste é correto afirmar:
I - A presença do HLA B27 aumento o risco para espondilite anquilosaste.
II - Os osteófitos e a redução do espaço vertebral na coluna lombar são achados radiográficos característicos.
III - A uveíte anterior é uma das manifestações extra articulares
IV - Os pacientes apresenta lombalgia que melhora com movimento associada a rigidez matinal
A. I, II e III
B. II, III e IV
C. I, II e IV
D. I, III e IV

30.Sobre a gota assinale a alternativa correta
A. O uso de ácido acetilsalicílico em altas dose em pessoas com hiperuricemia pode aumentar o risco de artrite aguda
B. Classicamente se manifesta como monoartrite aguda, que se instala rapidamente em poucas horas, com dor intensa e sinais flogísticos na articulação acometida
C. É importante fazer a medida do ácido úrico sérico logo no início da crise, para iniciar o hipouricemiante imediatamente.
D. Apesar de poder manifestar-se como crises repetidas de artrite, não provoca alterações permanentes nas articulações.

31.Um mulher de 18 anos procura assistência médica com queixa de eritema malar, fotossensibilidade, úlceras incolores no palato duro, anorexia e artrite nos joelhos há 1mês. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, qual o achado laboratorial encontrado?
A. Leucocitose com desvio a esquerda
B. Diminuição de C3 e C4
C. Presença de anti SCL 70
D. Fator reumatoide positivo.

32.Os corticosteroides são medicamentos de ação anti-inflamatória e imunossupressora. São utilizados parasuprimir os mecanismos de resposta imune, procedimento necessário para realizar o tratamento das doenças reumáticas imunomediadas. Sobre tais drogas, é correto afirmar:
A. Deve-se evitar a prescrição de prednisona em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa.
B. Pacientes em uso prolongado de altas doses de corticosteroides devem ser monitorizados quanto ao risco de hipoglicemia e hipotensão.

A prescrição de carbonato de cálcio e da vitamina D é indicada na prevenção de osteoporose corticoduzida.
D. A ação mineralocorticóide e a potência da prednisolona, prednisona, metilprednisolona edexametasona são idênticas.

33.Paciente de 24 anos comparece para consulta na UBS com queixas de "azia e queimação no estômago". Durante a anamnese você descobriu que essa paciente utilizava nimesulida, três vezes por semana, há quatro meses, em função de dor lombar mecânico postural. Podemos justificar esta sintomatologia dada a ação dos AINES inibindo a:
A. COX-1.
B. COX-2.
C. Fosfodiesterase.
D. Dihidrorato redutase.

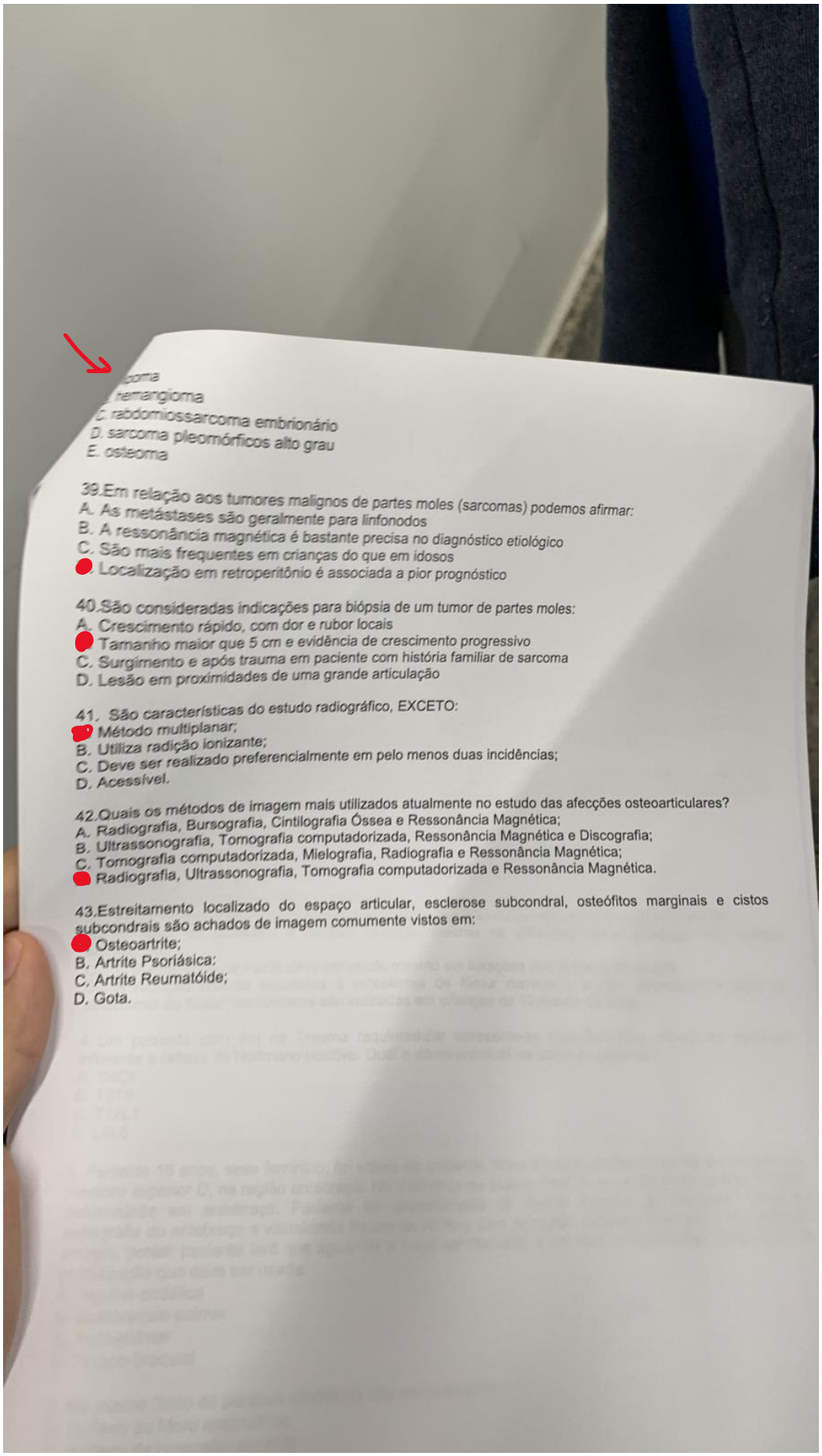
34.J.M.S., 56 anos, sexo feminino, católica, parda, casada, atendente de telemarketing, procedente e residente em Goiânia, apresenta como queixa principal: "Dor intensa no corpo todo e fadiga há 4 meses". Ela afirma que vinha bem quando, há 4meses, iniciou quadro de dor em região lombar, MMSS e MMII, bilateral, de intensidade moderada (5 em uma escala de 0 – 10), insidiosa, caracterizando essa dor como difusa nos membros acometidos. Refere que, há 3 meses, evoluiu com dor generalizada em todo corpo, de forma constante e de mesma intensidade, associada a fadiga, principalmente após esforço físico, cefaleia, depressão e obstipação intestinal. No exame físico não havia artrite, observando-se dor a palpação da musculatura de todo o corpo. Exames laboratorias: TSH, VHS e PCR normais, com o fator reumatóide negativo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta mais adequada é prescrever:
A. Prednisona.
B. Etoricoxibe.
C. Metotrexato.
D. Pregabalina.

35.A osteoporose é a doença metabólica mais frequente na população geral, afetando sobretudo mulheres pós- menopausa e homens idosos. Assinale os medicamentos cujo uso crônico se associa a um risco aumentado desta condição:
A. Hidroclorotiazida, heparina e carbamazepina.
B. Deflazacorte, heparina e carbamazepina.
C. Hidroclorotiazida, heparina e carbamazepina.
D. Deflazacorte, heparina e carisoprodol.

36.A osteoartrite é uma doença articular crônica, caracterizada por insuficiência cartilaginosa secundária a fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseos e metabólicos. Sobre a fisiopatologia desta doença, é correto afirmar:
A. Os condrócitos são a maior fonte de enzimas degradadoras, sintetizando e ativando proteases, as quais atuam no catabolismo da cartilagem.
B. O fator de crescimento fibroblástico e o fator de crescimento insulínico desempenham importante papel na síntese de proteases.
C. Uma vez ativados, os condrócitos produzem óxido nítrico, o qual exerce vários efeitos anabólicos, aumentando a síntese de proteoglicanos.
D. A diminuição do ativador de plasminogênio e o aumento do nível do inibidor da atividade de plasminogênio (PAI-1) são os responsáveis pela maior produção de plasmina, a qual ativa a colagenase.

37.Mulher de 60 anos, profissão de bordadeira, antecedente de hipotireoidismo e diabetes mellitus tipo 2, em uso regular de Puran T4 125 mcg/dia e Metformina 500 mg, 2 vezes/dia, menopausada há três anos, refere dor tipo queimação, dormência, sensação de edema e congestão das mãos e perda da habilidade manual em ambas as mãos, de início há dois anos e piora considerável nos últimos seis meses. Ao exame físico, apresenta teste de Tinel positivo, bilateralmente, e atrofia tenar, principalmente à direita; ausência de sinais de artrite em punhos e articulações das mãos. Considerando-se a principal hipótese diagnóstica para o caso, a sintomatologia bilateral pode ser explicada pelos seguintes fatores:
A. Idade da paciente e profissão laboral.
B. Antecedente de hipotireoidismo e diabetes mellitus tipo 2.
C. Profissão laboral e gênero feminino.
D. Idade da paciente e antecedente de menopausa.

38.Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, cor branca e residente em Goiânia. Procurou médico por apresentar cinco nódulos na coxa direita. Ao exame por imagem os nódulos medem em média 5,0cm cada um, são superficiais e não apresentam envolvimento neurovascular. O diagnóstico mais provável é:



...coma
...hemangioma
C. rabdomiossarcoma embrionário
D. sarcoma pleomórficos alto grau
E. osteoma

39.Em relação aos tumores malignos de partes moles (sarcomas) podemos afirmar:
A. As metástases são geralmente para linfonodos
B. A ressonância magnética é bastante precisa no diagnóstico etiológico
C. São mais frequentes em crianças do que em idosos
D. Localização em retroperitônio é associada a pior prognóstico

40.São consideradas indicações para biópsia de um tumor de partes moles:
A. Crescimento rápido, com dor e rubor locais
B. Tamanho maior que 5 cm e evidência de crescimento progressivo
C. Surgimento e após trauma em paciente com história familiar de sarcoma
D. Lesão em proximidades de uma grande articulação

41. São características do estudo radiográfico, EXCETO:
A. Método multiplanar;
B. Utiliza radição ionizante;
C. Deve ser realizado preferencialmente em pelo menos duas incidências;
D. Acessível.

42.Quais os métodos de imagem mais utilizados atualmente no estudo das afecções osteoarticulares?
A. Radiografia, Bursografia, Cintilografia Óssea e Ressonância Magnética;
B. Ultrassonografia, Tomografia computadorizada, Ressonância Magnética e Discografia;
C. Tomografia computadorizada, Mielografia, Radiografia e Ressonância Magnética;
D. Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética.

43.Estreitamento localizado do espaço articular, esclerose subcondral, osteófitos marginais e cistos subcondrais são achados de imagem comumente vistos em:
A. Osteoartrite;
B. Artrite Psoriásica;
C. Artrite Reumatóide;
D. Gota.